Nota Técnica SEI nº 1528/2024/MPO

Assunto: **CC 61202 – Projeto de Apoio as Redes Regionais de Atenção à saúde do Estado de São Paulo (Projeto ARAS-SP).**

Proponente: **Estado de São Paulo.**

Senhores membros da Comissão de Financiamentos Externos – Cofiex,

SUMÁRIO EXECUTIVO

O Projeto de Apoio às Redes Regionais de Atenção à Saúde do Estado de São Paulo oferece uma visão detalhada dos desafios enfrentados pelo setor de saúde no Estado de São Paulo, que é o proponente desta iniciativa. O Estado de São Paulo responde por mais de 32,2% do PIB nacional e ocupa 3% do território do país, com uma população de 44 milhões de habitantes. Uma grande parte dessa população reside em áreas marcadas por desigualdades sociais, incluindo o Vale do Ribeira, o Vale do Paraíba e Itapeva, onde há dificuldades significativas no acesso aos serviços de saúde. Embora o Estado disponha de uma extensa Rede de Serviços, problemas organizacionais comprometem a efetividade de sua cobertura, principalmente devido à falta de integração entre os serviços hospitalares e os demais níveis de assistência, especialmente os relacionados à atenção básica. Esses desafios incluem a fragmentação dos cuidados, dificuldades no acompanhamento de casos crônicos e a inadequação na atuação por conta da ausência de padronização, linhas de cuidado e protocolos de atendimento.

As ações propostas neste Projeto visam melhorar a qualidade dos serviços de saúde oferecidos à população usuária do SUS no Estado de São Paulo e incluem: a construção de dois novos hospitais nas Redes Regionais de Atenção à Saúde nº 8 (RRAS 8) e nº 12 (RRAS 12) contendo 499 leitos; melhorias e inovações no parque tecnológico das unidades de saúde estaduais na Região Metropolitana de São Paulo; implantação de novas tecnologias voltadas à Saúde Digital; execução de infraestrutura para tecnologia da informação e modernização dos equipamentos em 15 hospitais da administração direta contemplados neste projeto; modernização e aquisição de servidores, armazenamento de dados, segurança da informação, e a implementação de novas tecnologias, como telemedicina e informatização das unidades, facilitando o acesso a ferramentas de gestão.

O pedido de empréstimo ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) é de até US$ 230.000.000,00, com um prazo estipulado de 60 (sessenta) meses para o desembolso e execução das ações propostas.

ANÁLISE

A análise da presente Carta-consulta é pautada nos critérios definidos pela Resolução Cofiex nº 17, de 7 de junho de 2021, de forma que o Programa/Projeto proposto obteve a pontuação 3,610 para a análise técnica e 0,133 para áreas estratégicas.

1. Análise técnica: Pontuação total = 3,610/4,000

1 – DESENHO (1,698/1,800)

1.1. Justificativa do programa/projeto: coerência entre problemas apresentados, soluções propostas e resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,658/0,700.

1.1.1. Caracterização da situação existente, com a identificação e descrição dos problemas apresentados de forma clara e coerente com o propósito do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O "Projeto de Apoio às Redes Regionais de Atenção à Saúde do Estado de São Paulo - ARAS" está caracterizado de forma clara, oferecendo uma visão abrangente dos desafios atuais enfrentados pelo setor de saúde no Estado de São Paulo, proponente deste pleito. O pedido de empréstimo junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) é de até US$ 230.000.000,00, com uma contrapartida do Estado de São Paulo de aproximadamente US$ 113.000.000,00, provenientes de recursos tributários. O proponente, localizado no sudeste do país, informa que é responsável por mais de 32,2% do PIB e ocupa 3% do território nacional, com uma população de 44 milhões de habitantes (IBGE, 2022). Grande parte dessa população reside em áreas com grandes desigualdades sociais, como o Vale do Ribeira, o Vale do Paraíba e Itapeva, enfrentando barreiras e problemas no acesso aos serviços de saúde. Apesar da extensa Rede de Serviços no Estado, há problemas organizacionais que comprometem sua cobertura, como a falta de integração entre os serviços hospitalares e os demais níveis assistenciais, especialmente relacionado a atenção básica. Esses problemas incluem a fragmentação dos cuidados, dificuldades no acompanhamento de casos crônicos e uma atuação inadequada devido à ausência de padronização, linhas de cuidado e protocolos de atendimentos. Além disso, a estrutura dos serviços é antiga e não está adequadamente adaptada às novas necessidades assistenciais do SUS. O Estado de São Paulo possui diversos municípios com pequenas populações e grandes desigualdades socioeconômicas, enfrentando dificuldades para estruturar uma Rede de Atenção à Saúde (RAS) que atenda plenamente às necessidades de saúde de suas populações, a regionalização surge como a solução para alcançar eficiência dos recursos. A descrição dos problemas está clara e há coerência o propósito do Projeto.

1.1.2. Congruência entre as soluções propostas e a solução para os problemas apresentados. Pontuação atribuída = 1.

As medidas propostas para a regionalização das redes assistenciais de saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), incluem um conjunto de ações voltadas ao fortalecimento e à melhoria da oferta de serviços essenciais nas regiões mais pobres e vulneráveis do Estado de São Paulo, demonstrando alinhamento com os problemas identificados. Existe uma estreita relação entre as soluções propostas e a resolução dos desafios apresentados.

1.1.3. Coerência entre os resultados esperados e as soluções propostas. Pontuação atribuída = 1.

De modo geral, o Programa visa melhorar a qualidade das condições de saúde da população do Estado de São Paulo, usuários do SUS, por meio de diversas ações de investimento. A solução proposta inclui a construção de dois novos hospitais nas Redes Regionais de Atenção à Saúde nº 8 (RRAS 8) e nº 12 (RRAS 12); adequações e inovações no parque tecnológico das unidades de saúde estaduais da Região Metropolitana de São Paulo; implantação de novas tecnologias voltadas à Saúde Digital; execução de infraestrutura para tecnologia da informação e modernização dos equipamentos nos 15 hospitais da administração direta contemplados neste Projeto; além da modernização e aquisição de servidores, armazenamento de dados, segurança de dados, e a inserção de novas tecnologias, incluindo telemedicina e informatização das unidades atendidas, facilitando o acesso às ferramentas de gestão. As soluções propostas demonstram coerências com os resultados esperados após o investimento.

1.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O Projeto oferece um detalhamento abrangente das ações planejadas, onde a solução proposta contempla a construção de dois novos hospitais nas Redes Regionais de Atenção à Saúde, a modernização do parque tecnológico das unidades de saúde na Região Metropolitana de São Paulo, e a implementação de novas tecnologias voltadas à Saúde Digital. O projeto também prevê a modernização dos equipamentos em 15 hospitais da administração direta, a atualização dos servidores e a melhoria do armazenamento e da segurança de dados, além da introdução de tecnologias como telemedicina e informatização das unidades.

O Proponente destaca que, com a atualização das Unidades envolvidas e a renovação de um parque tecnológico obsoleto, espera-se ampliar o acesso a diagnósticos e tratamentos nas regiões mais necessitadas do estado, elevando a qualidade da assistência à saúde para os usuários do SUS. A justificativa para o Projeto foi apresentada de forma satisfatória, com soluções adequadas e bem fundamentadas.

1.2. Objetivos/componentes/produtos alinhados à solução proposta e aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,564/0,600.

1.2.1. Alinhamento do objetivo geral do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

O objetivo geral do Programa, em síntese, contribuir para a melhoria das condições de saúde da população do Estado de São Paulo por meio da estratégia de regionalização, com o objetivo de consolidar as Redes de Atenção à Saúde (RAS) e fortalecer a capacidade de gestão do estado. Nota-se estreito alinhamento entre o objetivo geral do projeto e as soluções propostas com o resultado pretendido.

1.2.2. Alinhamento dos objetivos específicos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os objetivos específicos delineados pelo Proponente envolve diversos aspectos de melhorias para as redes de atenção a saúde, e incluem: 1) Redefinir o perfil assistencial das unidades de saúde no processo de regionalização para melhorar o acesso e a qualidade dos serviços; 2) Apoiar a elaboração dos Planos Regionais Integrados para fortalecer a rede e a governança regional; 3) Implementar o Plano Diretor de Educação Permanente, valorizando os Centros Formadores e de Qualificação para o SUS; 4) Modernizar equipamentos e infraestrutura com foco em novas tecnologias para a saúde digital; 5) Melhorar a eficiência dos gastos e a qualidade dos serviços assistenciais, integrando os diferentes níveis de atenção e garantindo um acompanhamento mais completo dos pacientes; 6) Fortalecer a gestão populacional de saúde com a análise de grandes bancos de dados, aprimorando indicadores epidemiológicos e o monitoramento de programas; 7) Investir em novas tecnologias, como telemedicina e informatização, para melhorar a gestão e ampliar o acesso aos serviços de saúde; 8) Modernizar a infraestrutura e tecnologia dos hospitais nas RRAS 1 a 6, para melhorar a eficiência e preparar a rede para futuros desastres climáticos; 9) Construir novos hospitais nas RRAS 8 e 12, visando suprir a carência assistencial e agilizar o atendimento, especialmente para condições crônicas. Nota-se alinhamento direto dos objetivos específicos do Projeto em pleito com as soluções propostas e com os resultados esperados.

1.2.3. Alinhamento dos componentes do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

A estrutura elaborada pelo Proponente para implantação e execução do Projeto parece coerente. Os componentes citados no Projeto estão divididos em investimentos voltados à i. apoio aos processos de gestão com ênfase na regionalização da saúde; ii. infraestrutura e atualização do parque tecnológico; iii. inovação digital - saúde digital; iv. gestão do projeto.

1.2.4. Alinhamento dos produtos do programa/projeto com as soluções propostas e com os resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os produtos citados no Programa estão alinhados às soluções propostas e aos resultados esperados.

1.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações fornecidas pelo Proponente sobre a estrutura de distribuição dos recursos, divididos em componentes, subcomponentes e produtos resultantes, estão alinhadas e são coerentes. O Projeto demonstra conformidade com os objetivos estabelecidos, as soluções propostas e os resultados esperados, resultando em informações adequadas.

1.3. Coerência entre os indicadores e os resultados esperados. Pontuação atribuída = 0,282/0,300.

1.3.1. Descrição específica de cada indicador em relação ao respectivo resultado esperado. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores descritos pelo Proponente estão diretamente relacionados aos resultados esperados. Observa-se os indicadores possuem estreita relação com os objetivos específicos apresentados no Projeto. Destacam-se os indicadores: i. Número de novos leitos SUS instalados nas RRAS 8 e 12; ii. Média mensal de pacientes atendidos nos novos leitos instalados nas RRAS 8 e 12; iii. Número de atendimentos ambulatoriais e hospitalares realizados pela administração direta e autarquias; iv. Média de dias de permanência institucional dos hospitais gerenciados pela adm. Direta e Autarquias; v. Número de Planos Regionais Integrados elaborados; vii. Número de aplicações de tecnologia sustentadas no âmbito da secretaria de estado da saúde.

1.3.2. Indicadores mensuráveis com fórmula de cálculo correspondentes. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são mensuráveis e possuem as fórmulas de cálculo adequada.

1.3.3. Indicadores objetivos e passíveis de cálculo. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores são objetivos, estão atreladas às soluções propostas e são passíveis de cálculo. Como exemplo citam-se o indicador "Número de atendimentos ambulatoriais e hospitalares realizado pelas unidades gerenciadas pelas Organizações Sociais da Saúde (OSS)" que se pretende, após a execução do Projeto, ampliar em 18%.

1.3.4. Relevância e compatibilidade dos indicadores em relação aos resultados esperados. Pontuação atribuída = 1.

Os indicadores apresentados no Programa são relevantes e compatíveis com os resultados pretendidos.

1.3.5. Indicadores mensuráveis com prazos definidos e dados disponíveis dentro do tempo do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Os prazos para alcançar as metas planejadas, definidas nos indicadores, estão implícitos, presumindo-se que serão atingidos ao longo da implantação do Projeto (previsto para realizar-se ao longo de 05 anos), com a meta final sendo alcançada apenas ao término deste.

1.3.6. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

De modo geral, os indicadores citados na Carta-consulta são suficientes e concisos em relação aos resultados e objetivos pretendidos. O Proponente soube apresentar indicadores que abrangem todo o escopo das ações a serem realizadas com o investimento solicitado denotando adequada as informações.

1.4. Prazo de desembolso compatível e a adequada distribuição dos recursos no cronograma. Pontuação atribuída = 0,094/0,100.

1.4.1. Compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Os desembolsos estão planejados para ocorrer ao longo de 5 anos, distribuídos conforme a estrutura de componentes, subcomponentes e produtos definidas pelo proponente. De forma geral, ao longo de deste período, os investimentos estarão voltados principalmente às ações de reformas das unidades assistenciais de saúde e na atualização do parque tecnológico da rede hospitalar relacionada ao Projeto. Verifica-se compatibilidade do prazo de desembolso com a complexidade do Projeto.

1.4.2. Distribuição adequada dos recursos no cronograma de desembolso. Pontuação atribuída = 1.

Percebe-se distribuição adequada dos recursos nos componentes, subcomponentes e produtos elencados pelo Proponente. Dos recursos pleiteados, 80,43% serão destinados ao Componente 2, relacionado à infraestrutura e atualização do parque tecnológico das redes assistenciais envolvidas. O Componente 3, voltado à inovação digital, receberá 13,04% dos recursos. Para o Componente 4, que apoia os processos de gestão, serão alocados 2,61%. Finalmente, o Componente 1, que trata do apoio aos processos de gestão com ênfase na regionalização da saúde, contará com 3,,91% dos recursos.

1.4.3. Coerência entre componentes e distribuição dos recursos. Pontuação atribuída = 1.

Há certa coerência entre os componentes e a distribuição dos recursos pleiteados.

1.4.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O cronograma apresentado se demonstra adequado. A alocação de recursos para a implementação do Projeto foi apresentada de forma coerente demonstrando análise cuidadosa da equipe envolvida na preparação da Carta-consulta. Embora os recursos de contrapartida não foram distribuídos no cronograma apresentado, foi informado que o valor previsto, provenientes de recursos do estado de SP (U$ 113.000.000,00) será destinado à construção duas novas unidades hospitalares nos municípios de Birigui (274 leitos) e Itapetininga (225 leitos). As informações fornecidas no cronograma de desembolso são consideradas completas.

1.5. Justificativa da opção pelo financiamento externo e pelo agente financeiro. Pontuação atribuída = 0,100/0,100.

1.5.1. Justificativa de opção pelo financiamento externo em detrimento de opções de financiamento interno. Pontuação atribuída = 1.

Foi apresentada justificativa coerente para a escolha do financiador externo ao invés de agências de fomento nacionais. A decisão pelo financiamento externo é fundamentada nos custos financeiros mais baixos e nas condições mais favoráveis de empréstimo, que incluem prazos de carência mais longos, taxas de juros mais competitivas e melhores condições de amortização em comparação aos financiamentos nacionais.

1.5.2. Justificativa de opção pelo agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída =

1.

O proponente justifica de maneira adequada sua escolha pelo BID, destacando as taxas de juros mais baixas oferecidas, conforme demonstrado no anexo à Carta-consulta. Além disso, o proponente enfatiza a experiência positiva do BID em projetos de saúde no Brasil, especialmente no estado de São Paulo, como evidenciado pelo exitoso projeto de Fortalecimento da Gestão de Saúde. Informam que o Estado de São Paulo possui um histórico sólido de relacionamento com o BID, tendo recebido apoio em diversos projetos em várias áreas. O Proponente também destaca seu conhecimento e experiência com as normas de licitação do Banco, o que facilita o relacionamento com a instituição financeira.

1.5.3. Informações sobre as condições financeiras do agente escolhido para a operação de crédito pleiteada. Pontuação atribuída = 1.

São apresentadas informações detalhadas sobre as condições financeiras do agente definido para a tomada de empréstimo, que são: O agente escolhido, AFD, oferece condições financeiras mais atrativas que incluem:
- Prazo de Carência: 60 meses
- Prazo de Desembolso: 60 meses
- Prazo de Amortização: 180 meses
- Prazo Total do Financiamento: 240 meses
- Taxa de Juros: 1,66% + EURIBOR 6M a.a
- Comissão de compromisso: 0,50% a.a. sobre o saldo não desembolsado do empréstimo
- Comissão de Avaliação: 0,5%

1.5.4. Apresentação de comparativo das condições financeiras com outros agentes financeiros externos. Pontuação atribuída = 1.

Foi apresentado pelo Proponente um quadro comparativo contendo 04 agências de fomento externo (NDB, BIRD, CAF), incluindo o BID. Foi acrescentado comparativos de condições financeiras para empréstimos em bancos nacionais incluindo BNDES, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil

1.5.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

A justificativa apresentada pelo Proponente para a escolha do financiamento externo, assim como a comparação entre as agências internacionais e nacionais, foi elaborada de modo abrangente, revelando-se completa e precisa.

2 - GESTÃO (0,840/1,000)

2.1. Arranjo institucional adequado à implementação do programa/projeto (incluída a Matriz de Responsabilidade Institucional). Pontuação atribuída = 0,400/0,400.

2.1.1. Adequação da Matriz de Responsabilidade Institucional à operacionalização do programa/projeto, contendo principais atividades, órgãos envolvidos na execução e respectivas responsabilidades. Pontuação atribuída = 1.

A Matriz de Responsabilidade Institucional, no modelo RACI, foi apresentada em anexo à Carta-consulta e está adequadamente estruturada para a implementação do Projeto. Os órgãos responsáveis pela execução, assim como suas responsabilidades e funções específicas, estão claramente delineados. O arranjo de preparação do Programa contará com uma Unidade de Coordenação do Projeto (UCP), vinculada à Secretaria Estadual da Saúde (SES/SP), composta por servidores públicos encarregados de conduzir todas as atividades necessárias para a implementação das ações, após a aprovação do pleito.

2.1.2. Conhecimento do órgão executor sobre políticas de aquisição e salvaguardas do

agente financeiro externo escolhido. Pontuação atribuída = 1.

O Proponente destaca sua experiência com as políticas de contratação do agente financeiro selecionado, assim como com as políticas e salvaguardas ambientais. Além disso, enfatiza que as diretrizes e salvaguardas sociais do BID serão rigorosamente aplicadas ao Projeto.

2.1.3. Informação sobre a estrutura operacional (equipe técnica e experiência) para implementação do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

A Unidade de Coordenação do Projeto (UGP) será composta por profissionais altamente experientes nas políticas de aquisições de organismos internacionais financiadores. O Proponente informa que conta com uma equipe técnica própria, composta por especialistas em gestão, saúde, finanças, licitações e outras áreas essenciais para o Projeto. Essa equipe possui um histórico de sucesso na execução de programas financiados por organismos internacionais, como o Programa de Fortalecimento da Gestão na Saúde no estado de São Paulo, realizado entre 2014 e 2021, além de contar com o suporte de serviços de consultoria contratada especificamente para programas financiados.

2.1.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 5.

Foi constatado que há uma equipe experiente disponível para a implementação das ações previstas no Projeto, e as informações fornecidas sobre a estrutura operacional necessária para sua preparação e execução são adequadas. O Proponente apresenta informações detalhadas sobre o funcionamento da Secretaria de Saúde de São Paulo, o alinhamento estruturado junto ao Sistema Único de Saúde (SUS) e suas responsabilidades, que incluem: manter a rede assistencial própria do Governo do Estado; Gerir, planejar e regular a rede assistencial vinculada ao SUS; manter os órgãos estaduais de apoio às ações da Secretaria de Saúde; realizar, coordenar e planejar as ações de saúde coletiva no Estado; desenvolver ações de supervisão, capacitação, acompanhamento, avaliação e apoio aos sistemas de saúde municipais. As informações apresentadas são abrangentes, completas e atendem o contexto necessário para pontuação máxima no requisito

2.2. Operacionalização, manutenção e sustentabilidade financeira após o término do programa/ projeto. Pontuação atribuída = 0,176/0,300.

2.2.1. Indicação de medidas para operacionalização e manutenção das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

As medidas para operacionalizar e sustentar as ações decorrentes do Projeto, incluindo a garantia da sustentabilidade financeira após a conclusão das iniciativas, serão conduzidas pelas Secretaria de Estado da Saúde e as Secretarias Municipais de Saúde, que serão as responsáveis pela continuidade e pelo aporte dos recursos necessários.

2.2.2. Informação sobre a previsão de instrumentos e/ou medidas que garantam a sustentabilidade financeira das ações/equipamentos resultantes do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Há informações explícitas sobre a previsão de instrumentos ou medidas legais que assegurem a sustentabilidade financeira das ações decorrentes do Projeto. Todos os gastos decorrentes de novos serviços serão afiançados pelos instrumentos de planejamento e orçamento, coordenados pelas Secretarias Estaduais de Fazenda e de Planejamento, que incluem o PPA e a Lei Orçamentária Anual.

2.2.3. Previsão de custos de manutenção (custeio e reposição) após a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 0.

Não há informações claras sobre a previsão dos custos de manutenção após a conclusão do

Projeto.

2.2.4. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 2.

O Proponente apresenta informações sobre a operacionalização das ações após a implementação do Projeto nas Redes de Apoio especificadas. Referente ao custeio da manutenção, apesar de não ter sido informado os montantes necessários, é informado que estes constam na programação orçamentária da Secretaria de Estado da Saúde, SES/SP. As informações ainda estão imprecisas e carecem de complementos.

2.3. Compatibilidade com as prioridades das políticas de governo do proponente. Pontuação atribuída = 0,264/0,300.

2.3.1. Inserção do programa/projeto nos programas finalísticos do PPA ou nos planos de investimentos da empresa ou instituição financeira. Pontuação atribuída = 1.

Conforme destacado pelo Proponente, o Projeto está alinhado com o Plano Plurianual (PPA 2024-2027), especialmente no que diz respeito ao atendimento integrado e regionalizado no SUS no Estado de São Paulo. O PPA prevê a criação de uma Rede Integrada de Serviços que permita um acesso mais ágil dos usuários dentro de sua região. O plano enfatiza a necessidade de desenvolver e implantar políticas públicas robustas, oferecendo apoio técnico e financeiro aos municípios do estado, com o objetivo de fortalecer a governança da rede e ampliar os serviços para toda a população.

2.3.2. Informações sobre planos setoriais relacionados ao programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

O Proponente cita que as ações propostas no Programa estão alinhadas com o Plano Estadual de Saúde, com o Plano Plurianual (PPA), com o Plano Diretor de Regionalização (PDR) e com as Políticas Públicas do Ministério da Saúde.

2.3.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

De maneira geral, o Projeto está alinhado com o Plano Plurianual (PPA), refletindo a coerência com as estratégias e ações adotadas pelo Estado de São Paulo para promover melhorias na saúde das populações das regiões contempladas pelo Projeto. As informações apresentadas na Carta-consulta são aceitáveis.

3 - GERENCIAMENTO DE RISCO (1,072/1,200)

3.1. Atividades executadas, e/ou em andamento, como ações prévias à execução de programas/ projetos, que podem incluir, dentre outros: termos de referência, estudos, projetos de engenharia, licitações, desapropriações, licenciamentos e atos legais. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.1.1. Informações sobre o estágio das ações prévias necessárias à execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

Existem informações relevantes sobre o estágio das ações prévias necessárias para a execução do Programa em questão, que se baseiam no levantamento realizado pelo Programa de Fortalecimento de Gestão em Saúde no Estado de São Paulo, de 2014 a 2021. Esse levantamento destacou a necessidade urgente de investimentos em tecnologia para inovar nas práticas gerenciais e assistenciais no SUS. Em 2023 iniciou-se um processo para a estruturação e qualificação de estratégias de gestão com foco no processo de Regionalização da Saúde no Estado de São Paulo. Além disso, a Carta-consulta em sua versão atualizada apresenta informações relevantes relacionado as etapas já realizadas para a construção das duas novas unidades hospitalares (Itapetininga e Birigui) que incluem elaboração de projetos básicos, orçamentos, minutas de editais para processo de licitação entre outras medidas legais para viabilização dos

empreendimentos

3.1.2. Coerência entre as informações apresentadas e as necessidades relacionadas às atividades previstas para a execução do programa/projeto. Pontuação atribuída = 1.

As informações apresentadas pelo Proponente são coerentes e nota-se claramente as necessidades relacionadas às ações previstas para a execução do Projeto.

3.1.3. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

O Proponente informa ter realizado rodadas de oficinas em todas as regiões do Estado de São Paulo em que se verificou a necessidade de ações imediatas para qualificação e a implementação de ações visando fortalecer a governança e a resolutividade da gestão do SUS, além de investimentos em tecnologia e adequação da infraestrutura nas regiões mais carentes de recursos. Há informações relevantes relacionada aos avanços necessários para construção das duas novas Unidades hospitalares que serão financiadas pelos recursos do Projeto. As informações apresentadas na Carta-consulta estão adequadas.

3.2. Identificação de potenciais riscos e suas ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 0,376/0,400.

3.2.1. Detalhamento relacionado a atos legais e institucionais necessários, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Foi informado pelo Proponente que o arcabouço legal para a condução do Projeto está em implementação. A Carta-consulta cita que não haverá transferência de equipamentos para a gestão municipal, e que o processo de regionalização está em curso, tendo a adesão de todos os Munícipios, através de um compromisso formalmente assinado por ocasião da constituição de Comitês Executivos de Governança em todas as RRAS. (Documento anexo à Carta-Consulta: Deliberação CIB nº 87/23 e CIB nº 64/24

3.2.2. Detalhamento relacionado a contratações, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

Foi apresentado um detalhamento sobre as contratações, incluindo seus riscos e as ações mitigadoras propostas. As principais contratações estão associadas aos produtos listados nos componentes do Projeto e incluirão a aquisição de bens, consultorias e serviços. O Proponente identificou que os principais riscos estão relacionados a possíveis atrasos na elaboração dos documentos preparatórios de licitação, como planos de aquisição, termos de referência, projetos executivos, estimativas de custos e editais. Para mitigar esses riscos, o Proponente planeja utilizar a experiência dos gestores do programa com contratos de financiamento internacional e contará com apoio especializado em aquisições. Além disso, serão implementadas medidas de monitoramento e controle em todas as etapas de planejamento, licitação, contratação e conclusão, incluindo reuniões periódicas para avaliar o desempenho dos contratos, identificar possíveis problemas e elaborar planos de ação para garantir o cumprimento deles.

3.2.3. Detalhamento relacionado a desapropriação/reassentamento, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O Proponente informa que Projeto não envolve nenhuma ação de desapropriação ou reassentamento, uma vez que os terrenos previstos para a construção dos hospitais pertencem ao Estado de São Paulo e já estão disponíveis. Informa ainda que sua manutenção e custeio estão garantidos, não havendo nenhum risco de não se concretizar, visto que, assim que se iniciam as obras é aberto o Processo para
contratação da Organização Social parceira para a gestão da Unidade.

3.2.4. Detalhamento sobre impacto ambiental e social, riscos e ações mitigadoras. Pontuação atribuída = 1.

O proponente informa que a implementação das ações do Programa passará por acompanhamento permanente pelos conselhos estaduais e municipais de políticas públicas e garantias de direitos, implicando gestores públicos, técnicos da área, sociedade civil e beneficiários diretos. Para o risco de privilégio indevido na seleção de beneficiários, serão construídas ferramentas de mitigação que trarão com informações transparentes e objetivas, focando no público a ser beneficiado, conforme critérios técnicos legalmente estabelecidos. O Proponente demonstra compromisso com a legislação vigente e a política de sustentabilidade do BID, reconhecendo que empreendimentos de infraestrutura, como os novos hospitais do Projeto ARAS, podem causar impactos ambientais. O Projeto informa que as unidades hospitalares terão métodos construtivos que promovam a resiliência frente aos eventos de mudança climático, eficiência hídrica e energética e gestão integrada dos resíduos sólidos em saude, incluindo a certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Será adotado um sistema alinhado aos padrões do Marco de Política Ambiental e Social (MPAS) do BID, para mitigar riscos e melhorar o desempenho ambiental e social ao longo do ciclo de vida do projeto.

3.2.5. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 4.

As informações fornecidas no Projeto estão contextualizadas com as ações planejadas. Englobam a identificação dos principais riscos em cada área e as medidas para mitigá-los. O Proponente reapresenta a Carta consulta trazendo detalhamentos sobre atos legais e institucionais necessários e em andamento complementando as informações iniciais. As informações estão adequadas.

3.3. Experiência na execução de programas/projetos com agente financeiro externo. Pontuação atribuída = 0,320/0,400.

3.3.1. Experiência (e capacidade) do proponente na execução de operações de crédito externo. Pontuação atribuída = 1.

O Proponente afirma que possui experiência com agências financeiras para captação de crédito o que pôde ser confirmado ao consultar o sistema SIGS da SEAID e verificar os diversos contratos em execução.

3.3.2. Qualidade do Requisito. Pontuação atribuída = 3.

O cálculo a seguir foi realizado segundo às orientações da Obs. 4, da Resolução nº 17, de 7 de junho de 2021. Foi considerado na Carteira de contratos assinados do proponente apenas aqueles com datas superiores a 10 anos, sendo feito a exclusão das operações com menos de 1 (um) ano de execução e as operações de rápido desembolso ou reestruturação de dívida. Considerou-se a data de referência a data da reunião da Cofiex - 12/09/2024 - sendo o período considerado de 12/09/2014 a 12/09/2023.
Os Programas considerados, obtidos do Relatório Projetos Avaliados pela Média (retirados do SIGS) foram: 1) Projeto Aquisição de Trens para a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - BID (Nota 73,49); 2) Programa de Investimento Rodoviário do Estado de São Paulo - Fase 2 - Fonplata (Nota 50,24); 3) Programa de Apoio à Gestão de Integração dos Fiscos no Brasil PROFISCO II SP - BID (Nota 61,45); 4) São Paulo Ma Digital - BID (Nota 100); 5) Extensão da Linha 2 Verde - Aquisição Material Rodante - BID (Nota 100); 6) Empreendimento Rede Metroferroviaria de São Paulo - Linha 17 - Ouro - Trecho 1 Estacão Jardim Aeroporto Congonhas a Estacão Morumbi CPTM Sistema Monotrilho - CAF (Nota 35,8); 7) Sistema de Macrodrenagem do Rio Baquirivu Guaçu e Barragens Pedreira e Duas Pontes - CAF (Nota 20); 8)Programa de Logística e Transportes do Estado de São Paulo - SANTANDER (Nota 50). Média do desempenho da carteira: 61,37. Pontuação: 3 – Regular (média entre 50 a 70%). *Programas com dados no relatório cuja situação aponta "dados insuficientes" foram desconsiderados.

2. Áreas Estratégicas: Pontuação total = 0,133/2,000

1.1. promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não prevê ações diretas que justifiquem pontuação neste requisito, embora informe sobre a construção das duas novas unidades hospitalares (Itapetininga e Birigui) seguindo os princípios de sustentabilidade e resiliência ambiental e que irão buscar a certificação LEED.

1.2. eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não prevê ações que justifiquem pontuação neste requisito.

1.3. implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não prevê ações que justifiquem pontuação neste requisito.

1.4. gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não prevê ações que justifiquem pontuação neste requisito.

1.5. conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não prevê ações que justifiquem pontuação neste requisito.

1.6. melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não prevê ações que justifiquem pontuação neste requisito.

1.7. benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não prevê ações que justifiquem pontuação neste requisito.

1.8. geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não prevê ações que justifiquem pontuação neste requisito.

1.9. infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não prevê ações que justifiquem pontuação neste requisito.

1.10. ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não prevê ações diretas que justifiquem pontuação neste requisito, ainda que informe que haverá expansão de serviços de atendimento à saúde para a população negra, quilombolas,

aldeias e intramuros (penitenciários). Neste caso, o Projeto enquadra-se diretamento no item 1.13.

1.11. políticas voltadas para juventude, gênero e raça. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não prevê ações que justifiquem pontuação neste requisito.

1.12. melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão, de participação cidadã. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto está diretamente voltado à melhorias na prestação de serviços públicos, relacionados à saúde e envolve melhorias na gestão das redes assistenciais vinculadas à SES/SP. No entando, a pontuação será considerada apenas para o item correspondente às melhorias das condições de educação e saúde.

1.13. melhoria das condições de educação e saúde. Pontuação atribuída = 0,133.

O Projeto tem ações diretamente voltadas às melhorias na área da saúde para o Estado de São Paulo. Estas incluem investimentos para construção de dois novos hospitais nas Redes Regionais de Atenção à Saúde nº 8 (RRAS 8) e nº 12 (RRAS 12); adequações e inovações no parque tecnológico das unidades de saúde estaduais da Região Metropolitana de São Paulo; implantação de novas tecnologias voltadas à Saúde Digital; execução de infraestrutura para tecnologia da informação e modernização dos equipamentos nos 15 hospitais da administração direta contemplados neste Projeto; modernização e aquisição de servidores, armazenamento de dados, segurança de dados, e a inserção de novas tecnologias, incluindo telemedicina e informatização das unidades atendidas. Tais medidas, justificam a pontuação neste requisito.

1.14. desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não prevê ações diretas que justifiquem pontuação neste requisito, ainda que tenha diversas ações voltadas às melhorias e investimento em tecnologias, telemedicina, modernização nas redes hospitalares relacionadas ao pleito em tela.

1.15. arranjos de financiamento que incentivem/contribuam com a participação privada. Pontuação atribuída = 0,000.

O Projeto não prevê ações que justifiquem pontuação neste requisito.

CONCLUSÃO

Ao abordar questões críticas, como a fragmentação dos cuidados e a falta de integração entre os níveis de assistência em determinadas regiões do Estado de São Paulo, o Projeto ARAS-SP propõe ações que visam modernização da infraestrutura e implementação de novas tecnologias, tornando a rede de saúde estadual mais eficiente e acessível. O Projeto apresenta informações sólidas e demonstra a viabilidade de alcançar os resultados esperados dentro do período de investimento planejado, com potencial significativo para melhorar a qualidade dos serviços prestados à população usuária do SUS. O financiamento solicitado é essencial para viabilizar essas transformações, que prometem fortalecer a rede de saúde estadual e aprimorar as condições de atendimento à população.

A gestão do Programa está bem estruturada, com responsabilidades claramente definidas para sua implementação, e o Proponente possui ampla experiência na captação de empréstimos de agências externas. Dessa forma, o Projeto se destaca por sua relevância, sendo recomendada sua aprovação, assim como a autorização para o seu preparo junto ao agente financeiro escolhido.

RECOMENDAÇÃO

Diante do exposto, encaminha-se a presente análise à 178ª Reunião da Cofiex, com indicativo de aprovação.

À consideração superior.

Documento assinado eletronicamente

ALISSON VILAS BOAS

Analista em Ciência e Tecnologia

Documento assinado eletronicamente

PATRÍCIO PIAUÍ MAGALHÃES SILVA

Chefe de Divisão de Projetos de Infraestrutura

Documento assinado eletronicamente

WILLIAN BUENO E SILVA

Coordenador de Projetos de Infraestrutura

De acordo. Encaminhe-se ao Subsecretário de Financiamento Externo.

Documento assinado eletronicamente

DILSO MARVELL MARQUES

Coordenador-Geral de Projetos de Infraestrutura

De acordo.

Documento assinado eletronicamente

PAULO HENRIQUE MENDES LEANDRO BESERRA

Subsecretário de Financiamento Externo

Documento assinado eletronicamente por **Alisson Vilas Boas**, **Analista em Ciência e Tecnologia**, em 05/12/2024, às 10:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Patrício Piauí Magalhães Silva**, **Chefe(a) de Divisão**, em 05/12/2024, às 11:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Dilso Marvell Marques**, **Coordenador(a)-Geral**, em 05/12/2024, às 14:00, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Willian Bueno e Silva**, **Coordenador(a)**, em 05/12/2024, às 14:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por **Paulo Henrique Mendes Leandro Beserra**, **Subsecretário(a)**, em 05/12/2024, às 17:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.economia.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **46840984** e o código CRC **7A1F9D17**.

Referência: Processo nº 03101.002106/2024-83. SEI nº 46840984